

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

**FACTORES SOCIOCULTURALES COGNITIVOS ASOCIADOS AL
INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE
1 AÑO. CENTRO DE SALUD LIMA 2024**

CURSO:

INDAGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA II

AUTOR:

Vargas Quispe, Brhandom Daniel

ASESOR:

Arcaya Moncada, María

LIMA - PERÚ

2024

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Introducción	4
1.2. Planteamiento del problema	5
1.3. Objetivos	6
1.3.1. Objetivo general	6
1.3.2. Objetivos específicos	6
1.4. Importancia y alcance de la investigación	7
II. REVISIÓN DE LITERATURA	8
2.1. Antecedentes del estudio	8
2.1.1. Antecedentes Internacionales	8
2.1.2. Antecedentes Nacionales	9
2.2. Bases teóricas	12
2.2.1. Conocimiento general sobre las vacunas	12
2.2.2. Factores asociados	14
2.2.3. Teoría ecológica de Bronfenbrenner	16
2.2.4. Modelo de promoción de la salud de Nola Pender	17
III. HIPÓTESIS Y VARIABLES	18
3.1. Hipótesis	18
3.2. Variables	18
3.3. Operacionalización de variables	19
IV. MATERIALES Y MÉTODOS	21
4.1. Tipo y método de investigación	21
4.2. Diseño de investigación	21
4.3. Sede de estudio	21
4.4. Población, muestra y muestreo	21
4.4.1. Población	21
4.4.2. Muestra	22
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad	22
4.5.1. Técnicas e instrumento	22
4.6. Procedimiento de recolección y procesamiento de datos	22
4.7. Análisis estadístico	23
4.8. Consideraciones éticas	23

V. ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA	23
5.1. Cronograma de Gantt	24
5.2. Presupuesto	25
5.3. Recursos	25
5.3.1. Recursos humanos	25
5.3.2. Recursos materiales	25
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
VII. ANEXOS	30
MATRIZ DE CONSISTENCIA	30
CONSENTIMIENTO INFORMADO	32

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

La OPS emitió un comunicado el 15 de julio del 2021, “La pandemia de COVID-19 causa un importante retroceso en la vacunación infantil, según se desprende de los nuevos datos publicados por la OMS y el UNICEF”. En este comunicado informan que 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas administradas a través de los servicios de salud habituales en 2020, y en las Américas, la cobertura de vacunación sigue disminuyendo(1).

Por otra parte, la vacunación infantil en el Perú ha disminuido un 7.8% durante la pandemia del COVID-19 según un informe del UNICEF, además Loreto es la región con mayor porcentaje de niños menores de 3 años que no han recibido nunca una vacuna. Según cifras del Minsa, en Perú, la cobertura de vacunación de niños menores de 36 meses de edad pasó de 60.7% en el 2019 a 52.9% en el 2021. Según el informe del Estado Mundial de la Infancia (EMI) 2023, esta situación es consecuencia de la enorme presión que sufrieron los sistemas de salud, el desvío de los recursos hacia la vacunación contra el covid-19, la escasez de personal sanitario, las medidas de confinamiento en el hogar y la disminución de la confianza en las vacunas(2).

En el 2023, el Perú incrementó alrededor de 8 puntos porcentuales la cobertura de vacunación del esquema regular en menores de 1 año, tal como lo indica el informe “Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Magdalena Quepuy, directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud, resaltó que, en el 2023 se ejecutó el plan de cierre de brechas de vacunación en menores de 5 años y que para este 2024 se está ejecutando el mismo plan en todo el territorio nacional con el fin de proteger a la población infantil(3).

Las vacunas son la forma más segura y eficaz de protegerse y proteger a los demás contra las enfermedades prevenibles con vacunas(4). Vacunar a los niños es vital porque ayuda a brindarles inmunidad antes de que estén expuestos a

enfermedades posiblemente mortales. Las vacunas son evaluadas con el fin de garantizar su seguridad y eficacia para su posterior administración a los niños en las edades correspondientes(5). Entre las labores básicas de enfermería se encuentran el registro, control y gestión de las vacunas(6).

El Perú cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de la región, siendo el promedio regional en los esquemas regulares de vacunación de 13 vacunas, y el de Perú cuenta con 18 vacunas(7) Actualmente el esquema de vacunación del Perú está establecido por la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 “Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación” publicada el 9 de noviembre del 2022. Esta norma técnica incorpora la vacuna: Hepatitis A para niños y niñas de 15 meses; incorpora a los niños a la población objetivo de la vacuna contra VPH y la IPV como 3° dosis contra la polio(8).

1.2. Planteamiento del problema

La Organización Panamericana de Salud señaló la importancia de mantener las coberturas de inmunización por encima del 95% para evitar la propagación de microorganismos que producen enfermedades inmunoprevenibles. En el Perú, al término del año 2023, se identificó que no se logró alcanzar la cobertura óptima de vacunación, por lo que en “el informe de la ENDES publicado por el INEI, se señaló que el porcentaje de niños y niñas menores de 12 meses que completó el calendario de vacunación para su edad, según la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP8, alcanzó un 77.5%, en menores de 15 meses 75.2% y en menores de 36 meses de edad se consiguió inmunizar al 62.1%”(9). El reconocimiento de estos resultados, puso de manifiesto “la precarización del sistema sanitario, la ineficiente gestión de recursos humanos y la débil implementación de estrategias de vacunación para llegar a los lugares más lejanos del territorio nacional”, los cuales afectan de manera negativa la capacidad del personal de salud para brindar de manera exitosa el servicio de salud requerido por los usuarios que demandan el servicio de inmunizaciones.

En el informe sobre “El Estado Mundial de la Infancia 2023: Para cada infancia, vacunación”, se reporta que en Lima Metropolitana al término del año 2023,

tampoco se logró alcanzar la meta de inmunización respecto a la cobertura óptima, por lo que esta se ubicó “entre los territorios priorizados por Unicef en Perú, dado que la proporción de niñas y niños menores de 36 meses con cero dosis fue de 3.4%”. Así también, se reportó que el “porcentaje de niños y niñas menores de 12 meses que completó el calendario de vacunación para su edad alcanzó el 74.2%; en menores de 15 meses, la proporción fue de 71.6 y en menores de 36 meses de edad se consiguió inmunizar al 56.0%”. Ante estos resultados, se realizaron en los distintos establecimientos de salud “jornadas de vacunación nacional cuyo objetivo general fue cerrar las brechas existentes”

En el año 2023, la cobertura de vacunación en el menor de 1 año de la vacuna antipoliomielítica 3° dosis, Lima Centro se encontró en la zona de alerta con una cobertura del 78,30%. En la cobertura de la vacuna pentavalente 3° dosis, Lima Centro se ubicó en la zona de riesgo con un 82,37%. En la cobertura de vacunación en niños y niñas con SPR 2° dosis, Lima Centro se ubicó en la posición más baja, en zona de alerta con un 46,69% según el Registro de información HIS(10).

Esta realidad evidencia que el avance de la cobertura de vacunación infantil está siendo disminuido por varios factores, siendo los sociales y culturales los más significativos. Esta disminución de la cobertura de vacunación infantil en ciertas zonas del Perú es más visible y necesita mayor atención. Son necesarios más estudios a nivel nacional para identificar qué factores son los más frecuentes y qué acciones se pueden tomar en base a ello.

Por esta razón se hace necesaria la atención y reflexión realizando preguntas como: ¿Qué factores son más influyentes en el incumplimiento del esquema de vacunación infantil? ¿Por qué los índices de vacunación infantil no son mayores? De esta forma, finalmente se formula la pregunta de investigación: ¿Qué factores socioculturales cognitivos se asocian al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año en Lima-Centro?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar los factores socioculturales cognitivos presentes en las madres de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar los factores sociales presentes en las madres de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024.
- Identificar los factores culturales presentes en las madres de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024.
- Identificar los factores cognitivos presentes en la madre de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024.

1.4. Importancia y alcance de la investigación

El porcentaje de cobertura de vacunación en niños menores de 2 años en Lima Centro para ciertas vacunas se encuentra en zonas de alerta(10). En el área de inmunización, enfermería cumple un rol muy importante, por lo que el personal debe mantenerse en permanente actualización para brindar un cuidado de calidad, eficaz y eficiente. Enfermería no solo se encarga de la parte práctica de la inmunización, también tiene funciones como divulgar información sobre las vacunas a la población,

resolver sus dudas, inquietudes o preocupaciones de la sociedad en general, las personas y sus familias, sobre el tema(6).

La presencia de este problema es evidenciada a través de entrevistas a autoridades en centros de salud, informes emitidos por entidades gubernamentales y datos estadísticos publicados por el INEI. Razón por la cual este estudio pretende determinar qué factores se asocian al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año en un Centro de Salud en Lima-Centro.

La relevancia teórica de este estudio recae en su contribución al conocimiento actualizado de la realidad sobre los factores que retrasan la cobertura de la vacunación infantil en Lima-Centro.

La relevancia práctica de este estudio se basa en que los resultados permitirán que el personal de enfermería pueda reconocer los factores socioculturales que intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año y así poder tomar acción sobre ellos. Además, sirve como referencia o antecedente a futuras investigaciones relacionadas al tema para una ampliación sobre los factores que intervienen en el cumplimiento del esquema de vacunación.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Sigdel B. et al., en el año 2023, Nepal, publicaron un estudio titulado “Factores que afectan el cumplimiento de la vacunación infantil en el distrito de Ilam de Nepal; Un estudio de casos y controles”. Es un estudio analítico observacional de diseño de casos y controles. La población estuvo compuesta por madres/cuidadoras que tenían niños de 16 a 36 meses y vivían en 2 municipios del distrito de estudio. El tamaño de la muestra se calculó mediante el software estadístico Epi Info 7,

considerando un intervalo de confianza del 95%, agregando una tasa de falta de respuesta del 10% según la fórmula de Fleiss y determinó un total de 250 muestras (83 niños incompletamente inmunizados como caso y 167 niños completamente inmunizados como control). Para obtener la muestra se utilizó una técnica de muestreo por conglomerados de múltiples etapas. Para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario estructurado, escrito en inglés y luego traducido al nepalí por un experto bilingüe. Concluyendo que:

“La falta de información sobre la vacuna, la educación de los padres, la no vacunación por desabastecimiento, la falta de conocimiento sobre el calendario de vacunación y la actitud negativa hacia la vacunación se asociaron significativamente con el incumplimiento de la vacunación infantil”(11).

Muñoz T. et al., en el año 2021, México, publicaron un estudio titulado “Razones del incumplimiento del esquema básico de vacunación en una comunidad rural de Aguascalientes” cuyo objetivo fue desvelar las razones del incumplimiento del esquema básico de vacunación en una comunidad rural de Aguascalientes. Este estudio se basó en un enfoque cualitativo exploratorio, utilizando entrevistas directas a la población que eran las madres cuyos hijos tenían un esquema de vacunación incompleto. Se realizó un muestreo teórico en función de la unidad de análisis hasta que se alcanzó la saturación teórica con 11 entrevistas. Se concluyó que:

“Entre las razones propias de los apoderados para no completar el esquema de vacunación, el "temor" fue mencionado como un factor significativo. Sin embargo, la razón más frecuentemente expresada fue el "total desinterés" hacia la vacunación”(12).

Damyanthy K. et al., en el año 2019, Malasia, publicaron un artículo titulado “Factores sociodemográficos y de atención de la salud que determinan la falta de vacunación entre los niños en edad preescolar en

el distrito de Petaling, Selangor: un estudio transversal en Malasia” cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de personas que no cumplen con las vacunas infantiles y sus factores asociados entre los niños menores de 5 años que asisten a centros de cuidado infantil registrados en el distrito de Petaling, Selangor. Es un estudio de enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal y los datos se recogieron mediante un cuestionario a un total de 1015 madres. Concluyó que:

“Es necesario intensificar la implementación de programas de intervención para mejorar el estado de vacunación infantil centrándose en la comunidad no musulmana, las madres con bajo nivel educativo, las madres con múltiples hijos y las madres con hijos de 2 años o menos”(13).

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Moreno P. y Norma A., en el año 2023, Perú, publicaron una investigación titulada “Factores que afectan el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en menores de cinco años en América Latina” cuyo objetivo fue revelar con base a la literatura científica, los factores que afectan el cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 5 años en los diferentes países latinoamericanos en la última década. El estudio es de tipo revisión documental bibliográfica de artículos publicados entre los años 2013 y 2023 en bases de datos confiables. Se revisaron 13 artículos tras aplicar criterios de inclusión y exclusión. Concluyendo que:

“Entre los factores que afectan el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en niños menores de cinco años se encuentran los factores sociodemográficos haciendo mención a la edad de la madre del niño, su nivel de instrucción, el número de hijos nacidos vivos y los mitos e información errónea que puede traer con ella en relación a las inmunizaciones y sus efectos secundarios”(14).

Ricales E., en el año 2023, Perú, publicó un estudio titulado “Factores asociados al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años en el centro de Salud Alto Laran, Chincha 2023”. Es un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y corte transversal. La población estuvo conformada por 227 madres de niños menores de 5 años que asistieron al Centro de Salud Alto Laran Chincha. Mediante un muestreo de tipo probabilístico se obtuvo una muestra de 143 madres. Se concluyó que:

“Los factores de incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años en el Centro de Salud Alto Laran Chincha 2023, de acuerdo con las dimensiones sociodemográficas, institucionales y cognitivas, se encuentran presentes”(15).

Choque A., en el año 2022, Perú, publicó un estudio titulado “Conocimientos de las madres sobre la vacunación en menores de cinco años en la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de un Centro Materno Infantil, Villa María del Triunfo 2020”. El estudio es de enfoque cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por las madres de menores de 5 años que asisten a la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones del Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui. La muestra se obtuvo a través de la fórmula de muestreo probabilístico para población finita aleatoria simple y estuvo conformada por 123 madres. El instrumento utilizado fue un cuestionario y la técnica fue la encuesta. Concluye que:

“La mayoría de las madres que acuden a la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones del Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui no conocen sobre la vacunación de niños menores de cinco años”(16).

Aquino B. et al., en el año 2022, Perú, publicaron un artículo original titulado “Factores asociados al incumplimiento de la vacunación infantil de

Difteria, Pertussis y Tétanos en Perú, año 2019”. El objetivo del estudio fue determinar los factores asociados al incumplimiento del esquema de vacunación contra (DPT) en Perú en 2019. Es un estudio de tipo analítico retrospectivo de fuente secundaria basado en datos de 7187 madres entre 15 a 49 años respecto al esquema de vacunación de sus hijos mayores de 6 meses de edad obtenidos en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de Perú 2019. Se hizo un análisis bivariado y multivariado por medio de la prueba chi cuadrado de independencia ($p < 0.05$). Concluyendo que:

“Los factores índices de riqueza, edad de la madre, nivel educativo bajo, no tener un seguro de salud y tener más de dos hijos están asociados a un incumplimiento en el esquema de vacunación de la DPT”(9).

Palomino Q. y Keiko S., en el año 2020, Perú, publicaron una investigación titulada “Nivel de conocimiento de madres de niños menores de 5 años sobre inmunizaciones en la I.E.I. Condevilla Señor II, Lima-2019”. Es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. La población estuvo constituida por 450 madres de niños menores de 5 años de la I.E.I. Condevilla Señor II que estudiaron en la segunda mitad del año 2019. Para la muestra se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple conformado por 208 madres de familia. Se concluyó que:

“.....el 59% de madres de familia poseen un nivel de conocimiento sobre inmunizaciones intermedio, 34% un nivel alto y el 7% nivel bajo. En relación con el nivel de conocimiento según la dimensión de conocimientos generales de vacunas, el 47% presenta nivel alto, el 47% presenta nivel intermedio y el 6% presenta nivel bajo.....”(17).

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Conocimiento general sobre las vacunas

2.2.1.1. Vacuna

Es toda preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones, subunidades o partículas proteicas de los mismos(8).

2.2.1.2. Inmunización

Proceso por el que una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, mediante la administración de una vacuna(8).

2.2.1.3. Esquema de vacunación

Representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política nacional de vacunación e inmunización(8). En el Perú el esquema de vacunación actual está determinado por la “Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de vacunación - NTS N°196-MINSA/DGIESP-2022”. En este esquema los lactantes con edad <12 meses, presentan el siguiente esquema:

GRUPO OBJETIVO	EDAD	VACUNA	DOSIS
RECIÉN NACIDO	Recién nacido	Vacuna Bacilo de Calmette - Guérin (BCG)	Dosis Única
	2 meses	Vacuna Pentavalente	1era. Dosis

MENORES DE 1 AÑO		Vacuna Antipolio inactivada inyectable Vacuna contra Rotavirus Vacuna Neumococo	
	4 meses	Vacuna Pentavalente Vacuna Antipolio inactivada inyectable Vacuna contra Rotavirus Vacuna Neumococo	2da. Dosis
	6 meses	Vacuna Pentavalente Vacuna Antipolio Oral Vacuna Influenza Pediátrica	3era. Dosis 3era. Dosis 1era. Dosis
	7 meses	Vacuna Influenza Pediátrica	2da. Dosis

Fuente: "NTS N°196-MINSA/2022/DGIESP"

2.2.1.4. Niño con vacuna completa

Es la niña o el niño que de acuerdo con su edad ha recibido las vacunas de manera adecuada y oportuna según lo establecido en el Esquema Nacional de Vacunación vigente. Actividad desarrollada por el profesional de enfermería de manera periódica y sistemática(8).

2.2.1.5. Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)

Cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización, tiene una asociación temporal y no necesariamente causal(8).

2.2.1.6. Incumplimiento

Falta de ejecución u omisión de un deber, obligación, compromiso o normal; que trae consecuencias negativas en la vida de una persona(18).

2.2.2. Factores asociados

Características o circunstancias que se pueden manifestar en una persona o comunidad, generando una mayor probabilidad de conseguir un resultado determinado, que puede ser favorable o perjudicial(19). En esta investigación los factores asociados (sociales, culturales y cognitivos) pueden afectar el proceso de inmunización y causar el incumplimiento del esquema de vacunación.

2.2.2.1. Factores sociales

Parte de los factores que condicionan la salud y calidad de vida; se relacionan en su mayoría a la pobreza, miden el progreso de una persona, comunidad o país, ya que determinan las oportunidades o dificultades que se tienen para alcanzar el bienestar, por ejemplo: la procedencia, edad, el estado civil, el empleo y la educación(20).

- **Procedencia:** Es el espacio geográfico en donde una persona nace y habita, lo cual aporta características propias tales como el modo de pensar o de actuar. Está asociado a la situación económica, la condición social y las oportunidades para poder desarrollarse(21).
- **Edad:** Variable que indica el tiempo transcurrido, desde el nacimiento de la persona. Marca el inicio y fin de diversas etapas del ser humano y es un factor directamente ligado al estado de salud(22).
- **Estado civil:** Situación de las personas determinadas por sus relaciones de parentesco y convivencia de acuerdo a las diversas formas de unión conyugal. Entre los tipos de estado civil, encontramos: conviviente, casado, divorciado, viudo, soltero(23).

- Grado de instrucción: Nivel educativo más alto que una persona ha alcanzado. En el Perú el sistema educativo se organiza en dos etapas: Primera Etapa (educación básica) y Segunda Etapa (educación superior)(24).
- Ocupación: Alude a lo que una persona dedica su tiempo, desempeñando varias obligaciones o tareas, sea trabajo, empleo, actividad o profesión, a tiempo parcial o tiempo completo y ya sea informal o formal(25).

2.2.2.2. Factores culturales y cognitivos

La cultura son las creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo; por ejemplo, un grupo religioso, un grupo familiar, una comunidad o una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas(26). El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. Está relacionado con el conocimiento: proceso por el cual se aprende a utilizar la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y la planificación. El desarrollo cognitivo comprende la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es de las más importantes(27). Existen teorías que explican la relación entre lo cognitivo y lo cultural, afirmando que la cultura es un fenómeno social y para poder comprenderla, reproducirla e interpretarla son necesarios procesos de cognición y aprendizaje, como la memoria, el pensamiento, la inferencia y la representación(28).

2.2.3. Teoría ecológica de Bronfenbrenner

La teoría ecológica de Bronfenbrenner afirma que los rasgos de las personas se encuentran en relación al ambiente, lo que conlleva a

la formación de comportamientos, de los cuales existen 4 sistemas de ambientes(29):

- Microsistema: Ambiente directo del individuo como el hogar. Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo.
- Mesosistema: Relaciones entre uno o más ambientes directos.
- Exosistema: Contacto indirecto pero influyente en personas cercanas. Son las fuerzas que influyen en los microsistemas. Por ejemplo: la naturaleza del trabajo de los progenitores, etc.
- Macrosistema: Hace referencia a la cultura, las leyes de la sociedad:

Esta teoría proporciona un marco conceptual para justificar el aspecto sociocultural de la investigación. Según la teoría, varios sistemas y contextos, variantes en su proximidad al individuo, influyen en el desarrollo humano

Esta teoría se relaciona con la investigación porque permite analizar cómo las diferentes capas de influencias ambientales y sociales afectan las decisiones y conductas de las madres respecto al cumplimiento del esquema de vacunación de sus hijos, aludiendo principalmente al microsistema según la teoría ya que ese nivel involucra las interacciones más cercanas de la madre, como su relación con la familia y amigos cercanos.

2.2.4. Modelo de promoción de la salud de Nola Pender

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud. Se relaciona con 2 teorías: Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather (30).

Este modelo explica cómo las características y experiencias individuales, así como los conocimientos y afectos específicos de la conducta conducen a que el individuo participe o no en comportamiento de salud. Todo esto integrado en el diagrama del Modelo de Promoción de la Salud (30).

Las investigaciones realizadas a partir de este modelo, en el periodo mencionado, predominan en Brasil, Estados Unidos de América y México. Los grupos de personas en las que más se hacen, son adolescentes y adultos, las temáticas más mencionadas son: actividad física, estilos de vida saludable, enfermedades crónicas y obesidad, la gran mayoría de los investigadores, utilizan la totalidad de conceptos expresados en el modelo para la interpretación del fenómeno estudiado (31).

Los profesionales que más investigan en torno a este modelo, son de los campos de enfermería y sociología. Se ha notado un incremento de las investigaciones alrededor del Modelo de Promoción de la Salud en la última década, reflejo del interés de estos expertos por comprender las conductas promotoras de la salud, así como de las motivaciones que llevan a realizarlas (31).

El MPS de Nola Pender puede relacionarse con la investigación porque ofrece un marco teórico que permite entender los factores que influyen en las conductas de salud de las madres, en este caso, del incumplimiento del esquema de vacunación de sus hijos. El modelo también se enfoca en cómo los individuos toman decisiones de salud basadas en factores personales y ambientales, y cómo la promoción de la salud está relacionada con la modificación de esos factores. El aplicar este modelo a la investigación permite analizar los factores socioculturales cognitivos que influyen en el comportamiento de las madres, además permite entender factores psicológicos y socioculturales que afectan sus conductas de salud. En la investigación, factores

como el nivel educativo, las creencias y experiencias de las madres con el sistema de salud y sobre la vacunación pueden influir en el cumplimiento del esquema de vacunación de sus hijos.

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis

El incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año en el Centro de Salud San Fernando Lima – Centro 2024, está significativamente correlacionado con los factores socioculturales cognitivos de la madre del menor.

3.2. Variables

- Factores socioculturales cognitivos
- Incumplimiento del esquema de vacunación

3.3. Operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	DEFINICIÓN DE DIMENSIÓN	INDICADORES
Factores culturales y cognitivos	Los factores sociales son algunos factores que condicionan la salud y calidad de vida; se relacionan en su mayoría a la pobreza, miden el progreso de una persona, comunidad o país, ya que determinan las oportunidades o dificultades que se tienen para alcanzar el bienestar.	Social	Constituida por factores que determinan las oportunidades o dificultades que se tienen para alcanzar el bienestar, por ejemplo: la procedencia, edad, el estado civil, el empleo y la educación, etc.	Sexo
				Edad de la madre
				Grado de instrucción
				Estado civil
				Medios de comunicación usados para informarse sobre la vacunación infantil
				Área de procedencia
				Número de hijos
	Los factores culturales abarcan desde las creencias, valores hasta los comportamientos que se comparten en un grupo. Los factores cognitivos se basan en el desarrollo cognitivo mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia	Cultural	Incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas	Trabajo
				Religión
				Idioma
				Facilidad de acceso a la vacunación
				Miedo frente a la vacunación de su hijo
				Confianza en la vacunación para evitar enfermedades

				Restricciones para vacunar a su hijo
				Influencia para vacunar a su hijo
		Cognitivo	Información y habilidades adquiridas a través de las capacidades mentales a lo largo del tiempo. Es la acción y efecto de conocer y comprender la realidad usando la razón.	Conocimiento adquirido sobre las vacunas
				Opinión sobre la importancia de la vacunación

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE

Son los factores que condicionan la salud y calidad de vida. Abarcan campos como el lenguaje, religión, el aprendizaje y experiencia en madres de niños menores de 1 año del centro de salud San Fernando y sus dimensiones son lo social, cultural y cognitivo, factores medidos por un cuestionario de escala nominal.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Tipo y método de investigación

Es un estudio de enfoque cuantitativo, caracterizado por buscar la explicación de la realidad vista desde una perspectiva externa y objetiva, en donde los datos son producto de las mediciones realizadas a las variables observadas del objeto de estudio. Es transversal porque recoge los datos en un solo momento(32).

4.2. Diseño de investigación

Se trata de un diseño no experimental, correlacional, pues no hay condiciones experimentales que guíen las variables de estudio y los sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural. Tiene alcance correlacional ya que busca saber cómo se comporta una variable según otra variable correlacionada(33).

4.3. Sede de estudio

El estudio se realizará en el Centro de Salud “San Fernando”, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, dirección Jr. Las Ortigas 1893 Urb. San Hilarión – Altura Pdo.13 Av. Las Flores. El C.S. San Fernando pertenece al Directorio de Establecimientos de Salud DIRIS LIMA CENTRO, contando con el M.C. José Francisco Verástegui Acuña como médico jefe. Es un establecimiento de Salud de categoría I-3. (34,35).

4.4. Población, muestra y muestreo

4.4.1. Población

La población estará conformada por madres de niños y niñas que acudan al Centro de Salud “San Fernando” y tengan faltas en el esquema de vacunación regular. Según los registros del último mes, al día acuden 2 niños menores de 1 año al servicio de inmunización, haciendo una inferencia al mes, sería una

población de 48 niños menores de 1 año. Además, tienen que cumplir con los siguientes criterios:

4.4.1.1. Criterios de inclusión

- Madres de niños menores de 1 año
- Residentes de Lima Centro
- Madres que acepten participar en el estudio

4.4.1.2. Criterios de exclusión:

- Madres de niños con esquema de vacunación puntual
- Madres de niños con VIH o inmunosupresión severa
- Madres de niños con reacciones adversas a la vacuna pentavalente
- Madres con niños que tengan alergia a las proteínas del huevo y no puedan colocarse la vacuna contra la influenza

4.4.2. Muestra

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita, teniendo como población las 72 niños menores de 1 año de edad que acuden al servicio de inmunización del centro de salud San Fernando.

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

n= Tamaño de muestra buscado

N= Tamaño de la población o universo = 48

Z= Parámetro estadístico que depende del Nivel de Confianza = 1.96

e= Error de estimación máximo aceptado = 5%

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado = 50%

q= (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento = 50%

Se resuelve:

$$n = 42.77 = 42$$

El tamaño de la muestra buscado para este proyecto de investigación es de 42, es decir, estará conformada por 61 niños menores de 1 año que no tengan completo su respectivo esquema de vacunación.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad

4.5.1. Técnicas e instrumento

La técnica utilizada para recolectar datos es la entrevista porque se trata de obtener de manera sistemática, fehaciente y real, información sobre las variables que intervienen en la investigación. (36).

El instrumento utilizado es un cuestionario realizado por fuente propia titulado “Factores socioculturales cognitivos y el incumplimiento del esquema de vacunación infantil”. Los ítems del instrumento se dividen en 3 dimensiones: Social, cultural y cognitivo.

La estructura del instrumento está conformada por: Presentación, instrucciones, y 21 ítems.

4.6. Procedimiento de recolección y procesamiento de datos

Se solicitarán los permisos correspondientes, empezando con cumplir los requisitos de la DIRIS LIMA CENTRO entre los que se encuentra la carta de presentación emitida por la institución a la que pertenece el investigador, también la aprobación del comité de ética para realizar dicha investigación y por último solicitar el permiso para proceder con la recolección de datos a través de una solicitud explicando el motivo del estudio, el método que se va a emplear y la confidencialidad de los datos.

Posterior a la aprobación del proyecto se aplicará el cuestionario, el cual contendrá preguntas sobre factores socioculturales cognitivos y el incumplimiento del esquema de vacunación. La aplicación del instrumento será ejecutada verificando que los participantes comprendan todas las preguntas. Todos los datos recopilados serán manejados y almacenados de forma segura y confidencial, respetando la privacidad de los participantes.

4.7. Análisis estadístico

Los datos recolectados serán analizados a través de la elaboración de tablas y gráficos para presentar los resultados y cumplir con los objetivos generales y específicos.

4.8. Consideraciones éticas

En la Declaración de Helsinki World Medical Association (2019), se establecen principios éticos fundamentales que rigen la investigación que involucra a seres humanos. En esta declaración el punto central es el principio de dar preferencia al bienestar del participante sobre los intereses de la ciencia y la sociedad (37). Los principios presentes durante la realización de esta investigación comprenden:

- Respeto de la autonomía: Reconocer la capacidad de la persona para tomar sus propias decisiones. A partir de esto, se protege la dignidad y libertad.
- Beneficencia: Responsabilidad del investigador para ser más cuidadoso sobre el bienestar físico, mental y social del participante. La principal responsabilidad es la protección del participante. Implica no hacer daño o reducir los riesgos al mínimo, por eso también es conocido como el principio de No Maleficencia.
- Justicia: Prohíbe exponer a riesgos a un grupo para beneficiar a otro, ya que se deben distribuir riesgos y beneficios de manera equitativa

V. ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1. Cronograma de Gantt

ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO	AÑO									
	2024									
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Planteamiento y formulación del problema	X	X								
Elaboración de objetivos, justificación y limitaciones		X	X							
Revisión de la literatura			X							
Identificación y operacionalización de variable			X							
Materiales y métodos			X	X						
Técnicas e instrumentos de recolección y matriz de consistencia del instrumento				X						
Adecuación administrativa				X						
Solicitud al Centro de Salud San Fernando para realizar el estudio						X				
Aprobación para la ejecución del estudio por parte del Centro de Salud San Fernando							X			
Aplicación del cuestionario									X	
Procesamiento (redacción de datos, elaboración de matriz y libro de códigos), presentación y análisis de datos									X	
Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones									X	
Revisión y reajuste del informe final									X	
Presentación del proyecto culminado									X	
Aprobación del informe final										X
Presentación y sustentación de tesis										X

5.2. Presupuesto

BIENES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Laptop	1	S/.1500.00	S/.1500.00
Hojas bond	1 paquete (millar)	S/.12.00	S/.12.00
Lapiceros	12	S/.1.00	S/.12.00
SERVICIOS			
Internet	10 meses	S/.30.00	S/.300.00
Luz	10 meses	60	S/.600.00
Fotocopias e impresiones de encuesta	160	S/. 0.10	S/. 16.00
Movilidad local	20	S/. 8.00	S/. 160.00
Estadística	----	S/. 300	S/.300.00
TOTAL (S/.)			2888.00

5.3. Recursos

5.3.1. Recursos humanos

- Investigador: Brhandom Daniel Vargas Quispe
- Asesora del proyecto: María Arcaya Moncada

5.3.2. Recursos materiales

Los materiales necesarios para el proyecto son los siguientes: 1 laptop millar de hojas bond A4 y 12 lapiceros.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OPS. La pandemia de COVID-19 causa un importante retroceso en la vacunación infantil, según se desprende de los nuevos datos publicados por la OMS y el UNICEF - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2021 [citado 17 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2021-pandemia-covid-19-causa-important-e-retroceso-vacunacion-infantil-segun-se>
2. El Peruano. El Peruano. 2023 [citado 17 de junio de 2024]. Vacunación infantil bajó en Perú. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/210653-vacunacion-infantil-bajo-en-peru>
3. Ministerio de salud. Perú incrementa casi 8 puntos porcentuales en la vacunación del esquema regular en menores de 1 año [Internet]. 2024 [citado 17 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/921316-peru-incrementa-casi-8-puntos-porcentuales-en-la-vacunacion-del-esquema-regular-en-menores-de-1-ano>
4. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. 2024 [citado 17 de junio de 2024]. Vacunas e Inmunización | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. Disponible en: <https://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html>
5. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. 2020 [citado 17 de junio de 2024]. Por qué vacunar. Disponible en: <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/index-sp.html>
6. Asociación de Enfermería Comunitaria. ENFERMERÍA Y VACUNAS [Internet]. [citado 17 de junio de 2024]. Disponible en: <http://proyectoavatar.enfermeriacomunitaria.org/enfermeria-y-vacunas>
7. UNICEF. En los últimos tres años el mundo perdió los avances de más de una década en inmunización infantil [Internet]. 2023 [citado 20 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/ultimos-tres-anos-mundo-perdio-avances-mas-de-una-decada-inmunizacion-infantil-informe-unicef>
8. Norma Técnica de Salud.pdf [Internet]. [citado 20 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3823311/Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud.pdf?v=1668009871>
9. Aquino Sosa BA, Correa López LE, Loo Valverde M, Alatriza Gutiérrez de Bambaren M del S, Guillen Ponce NR. Factores asociados al incumplimiento de la vacunación infantil de difteria, pertussis y tétanos en Perú, año 2019. RFMH Rev Fac Med Humana. 2022;22(2):345-52.
10. mclcp-sub-gt-inmunizaciones-18042024-dt.pdf [Internet]. [citado 20 de junio de 2024]. Disponible en:

<https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2024-04-23/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-18042024-dt.pdf>

11. Sigdel B, Jin Y, Dhakal P, Luitel T, Ghimire PK, Wasti SP. Factors affecting on compliance of childhood immunization in Ilam District of Nepal; A case-control study. *Dialogues Health*. 1 de diciembre de 2023;2:100140.
12. Muñoz-Trinidad J, Villalobos-Navarro A, Gómez-Chávez JR, Loera-Díaz IND, Nieto-Aguilar A, Macías-Galaviz MT. Razones del incumplimiento del esquema básico de vacunación en una comunidad rural de Aguascalientes. *Lux Médica* [Internet]. 3 de mayo de 2021 [citado 21 de junio de 2024];16(47). Disponible en: <https://revistas.uaa.mx/index.php/luxmedica/article/view/3149>
13. Krishna D, Mohd Zulkefli NA, Md Said S, Mahmud A. Sociodemographic and health care factors in determining immunization defaulters among preschool children in Petaling District, Selangor: a cross-sectional study in Malaysia. *BMC Public Health*. 18 de septiembre de 2019;19(1):1275.
14. Factores que afectan el cumplimiento del calendario de inmunizaciones en menores de cinco años en América Latina [Internet]. [citado 21 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/4db2bfee-db46-43e4-9889-58b6de3f55ef/content>
15. Sarcines MCB. TESIS: RICALES SALVATIERRA ERENI LEYA CÓDIGO ORCID: 0009-0002-0400-9398.
16. Choque A. Conocimientos de las madres sobre la vacunación en menores de cinco años en la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de un Centro Materno Infantil, Villa María del Triunfo 2020 [Internet]. 2022 [citado 21 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/cb0e4505-0fe8-4a0f-8578-d431dd9c474c>
17. Quiliche P, Silvana K. ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS. 2019;
18. El incumplimiento de la norma y la relación con la autoridad en el Perú | Fernando Del Mastro [Internet]. IUS 360. 2020 [citado 22 de junio de 2024]. Disponible en: <https://ius360.com/el-incumplimiento-de-la-norma-y-la-relacion-con-la-autoridad-en-el-peru-fernando-del-mastro/>
19. Riesgo.pdf [Internet]. [citado 22 de junio de 2024]. Disponible en: <http://www.cii.org.ar/Riesgo.pdf>
20. Sac SE. determinantes sociales.
21. mof-2013-parte1.pdf [Internet]. [citado 22 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/338715/mof-2013-parte1.pdf>
22. Ávila NR. Envejecimiento: Edad, Salud y Sociedad.

23. Perú: Cambios en el estado civil o conyugal 1981-2017 [Internet]. [citado 23 de junio de 2024]. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1742/Libro.pdf
24. DEFINICIONES BÁSICAS Y TEMAS EDUCATIVOS INVESTIGADOS [Internet]. [citado 23 de junio de 2024]. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1257/cap04.pdf
25. de Arregui PM. Empleo, ingresos y ocupación de los profesionales y técnicos en el Perú.
26. Definición de cultura - Diccionario de cáncer del NCI - NCI [Internet]. 2011 [citado 23 de junio de 2024]. Disponible en:
<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/cultura>
27. INVANEP. Desarrollo cognitivo del ser humano | blog_invanep [Internet]. 2020 [citado 24 de junio de 2024]. Disponible en:
https://invanep.com/blog_invanep/desarrollo-cognitivo-del-ser-humano
28. Salazar TR. Cultura y cognición: entre la sociedad y la naturaleza. Rev Mex Sociol. 2006;
29. La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner [Internet]. 2015 [citado 3 de julio de 2024]. Disponible en:
<https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-ecologica-bronfenbrenner>
30. eu114c.pdf [Internet]. [citado 3 de julio de 2024]. Disponible en:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2011/eu114c.pdf>
31. Aristizábal-Hoyos GP, Blanco-Borjas DM, Sánchez-Ramos A, Ostiguín-Meléndez RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Enferm Univ [Internet]. 2011 [citado 3 de julio de 2024];8(4). Disponible en:
<https://revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/248>
32. Novoa CAB. Investigación cuantitativa. 2017;143.
33. Arias_S2.pdf [Internet]. [citado 25 de junio de 2024]. Disponible en:
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
34. Centro De Salud San Fernando en San Juan De Lurigancho | MINSA [Internet]. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. [citado 25 de junio de 2024]. Disponible en:
<https://www.establecimientosdesalud.info/lima-centro/centro-de-salud-san-fernan-do-san-juan-de-lurigancho/>
35. Directorio Establecimientos [Internet]. DIRIS LIMA CENTRO. [citado 25 de junio de 2024]. Disponible en:
<https://dirislimacentro.gob.pe/directorio-establecimientos/>

36. tipos_encuestas.pdf [Internet]. [citado 25 de junio de 2024]. Disponible en:
https://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF
37. Principios generales de ética - Universidad de Chile [Internet]. [citado 25 de junio de 2024]. Disponible en:
<https://uchile.cl/investigacion/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-bioetica/documentos/principios-generales-de-etica>

VII. ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN, MUESTRA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
¿Qué factores socioculturales cognitivos se asocian al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año de edad en el centro de salud San Fernando, 2024?	Objetivo general: Determinar qué factores socioculturales cognitivos presentes en madres de niños menores de 1 año se asocian al incumplimiento del esquema de vacunación del menor Objetivos específicos: Identificar los factores sociales presentes en las madres de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024. Identificar los factores culturales presentes en las madres de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro	El incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año en el Centro de Salud San Fernando Lima – Centro 2024, está significativamente correlacionado con los factores socioculturales cognitivos de la madre del menor.	Variable: - Factores socioculturales cognitivos Dimensiones: - Social - Cultural - Cognitivo Variable: - Incumplimiento del esquema de vacunación	Tipo de investigación: Cuantitativo Diseño de investigación: No experimental Correlacional Corte transversal	Población: Madres con niños menores de 1 año que asistan al área de inmunización del centro de salud San Fernando Sede de estudio: El estudio se realizará en el Centro de Salud “San Fernando”, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, dirección Jr. Las Ortigas 1893 Urb. San Hilarión – Altura Pdo.13 Av. Las Flores. El C.S. San Fernando pertenece al Directorio de Establecimientos de Salud DIRIS LIMA CENTRO, contando con el M.C. José Francisco Verástegui Acuña como médico jefe. Es un establecimiento de Salud de categoría I-3.	Técnica: Entrevista semiestructurada Instrumento: Cuestionario

	de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024. -Identificar los factores cognitivos presentes en la madre de niños menores de 1 año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el Centro de Salud “San Fernando”, Lima, Perú 2024.					
--	---	--	--	--	--	--

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Luego de haber sido informado(a) sobre los puntos clave de la presente investigación como los objetivos, justificación y propósito, otorgo mi consentimiento para que se realice la encuesta a mi persona, teniendo claro que mi participación es anónima y toda información será confidencial sólo de uso para fines de esta investigación.

Acepto de forma voluntaria participar en el estudio de investigación de título “Factores socioculturales cognitivos asociados al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año en el centro de salud San Fernando, Lima – Perú 2024” cuyo objetivo es determinar qué factores socioculturales cognitivos están presentes en las madres de niños menores de un año asociados al incumplimiento del esquema de vacunación del menor en el centro de salud San Fernando, Lima – Perú 2024, realizado por el estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Brhandom Daniel Vargas Quispe.

Lima ____ de Agosto del 2024

Firma

**CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR PRESENCIA DE FACTORES
SOCIOCULTURALES COGNITIVOS PRESENTES EN MADRES DE NIÑOS
MENORES DE 1 AÑO ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE
VACUNACIÓN DEL MENOR EN UN C.S. NIVEL I-3, 2024**

Fecha: ____ / ____ / ____

PRESENTACIÓN

Estimado(a) madre/padre de familia, soy Vargas Quispe Brhandom Daniel, estudiante de enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy realizando un estudio que tiene como objetivo Determinar los factores socioculturales cognitivos asociados al incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año del Centro de Salud "San Fernando", Lima – Perú, 2024, para el cual solicito su colaboración para responder con la mayor sinceridad, el cual mejorará las intervenciones para su prevención. La información que Ud. proporcionará es anónima y se empleará solo con fines académicos. Agradezco por anticipado su colaboración.

A. Datos generales:

INSTRUCCIÓN:

Marcar con una aspa (X) la alternativa considere correcta (según su opinión), o completar los datos según corresponda especificar la información adicional requerida.

Datos sociodemográficos:

- 1) Edad: ____ años
- 2) Sexo:
 - a) Masculino
 - b) Femenino
- 3) Nacionalidad: _____
- 4) ¿Cuenta con seguro social?
 - a) Si
 - b) No
- 5) ¿Cuántos hijos tiene?
 - a) Ninguno
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 4 o más
- 6) ¿Cuál es su grado de instrucción?
 - a) Sin estudios
 - b) Primaria
 - c) Secundaria
 - d) Técnico
 - e) Superior
- 7) ¿Cuál es su estado civil?
 - a) Soltero(a)
 - b) Casado(a)
 - c) Conviviente
 - d) Viudo(a)

- e) Divorciado(a)
- 8) ¿De dónde proviene?
- a) Región amazónica
 - b) Región andina
 - c) Región costera
 - d) Otro. Especificar:
- 9) ¿Qué tipo de trabajo tiene?
- a) Comerciante
 - b) Trabajo doméstico
 - c) Profesional
 - d) Técnico
 - e) Otro. Especificar:
- 10) ¿Cuál es el principal medio de comunicación que utiliza para informarse sobre las vacunas de su hijo?
- a) Televisión y/o radio
 - b) Redes sociales
 - c) Canales oficiales de organismos de salud
 - d) Familiares o conocidos
 - e) Ninguno

ÍTEMS CULTURALES COGNITIVOS	
11) ¿Cuál es la religión que profesa?	a) Católico b) Evangélico c) Testigo de Jehová d) Ninguna e) Otro. Especificar:
12) ¿Tiene alguna restricción(limitación o prohibición) para vacunarse? Si la respuesta es "Sí", ¿por qué?	a) Si b) No Porque
13) ¿Cuál es la principal barrera que influyó en el incumplimiento del esquema de vacunación de su hijo?	a) Económica b) Cultural c) Cognitiva d) Acceso geográfico e) Tiempo
14) ¿Qué idioma o lengua habla?	a) Quechua - Castellano b) Aimara - Castellano c) Sólo Castellano d) Otro. Especificar:
15) ¿Considera importante vacunarse? ¿Por qué?	a) Si b) No Porque
16) ¿Confía en las vacunas para evitar las enfermedades? ¿Por qué?	a) Si b) No Porque
17) ¿Quién influyó en la decisión de vacunar a su hijo?	a) Mi cónyuge/pareja b) Mis padres c) Hermanos d) Otros. Especificar:

	e) Ninguno
18) ¿Cuál es su principal temor frente a la vacunación de su hijo?	a) Malestar posterior a la vacuna b) Enfermarse c) Otro. Especificar: d) Ninguno
19) ¿Qué conoce sobre las vacunas?	
20) ¿Qué efectos secundarios pueden ocasionar las vacunas?	a) Dolor en el lugar de la inyección, irritabilidad, fiebre baja b) Dolor en el lugar de la inyección, fiebre, tos c) Tos, fiebre, picazón d) Vómitos, picazón, dolor de cabeza
21) ¿Cuánto tiempo suelen durar los efectos secundarios de las vacunas?	a) Unos minutos b) Unas horas c) Un par de días c) Una semana

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!